



TALLER 11

Más allá del prisma

Programa de Formación para Profesionales de la Salud Mental

Presentación del Caso: El Laberinto del Olvido y la Furia Crepuscular

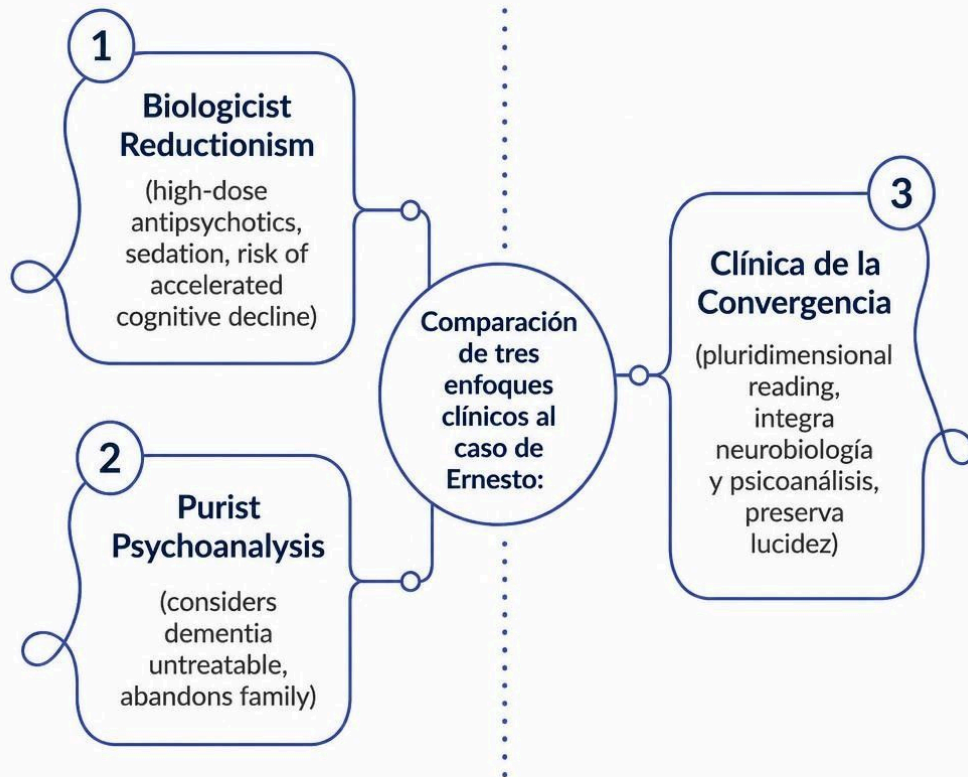
El paciente

Ernesto, de setenta y ocho años, exprofesor de literatura, cursaba un cuadro de enfermedad de Alzheimer en estadio moderado. Fue motivo de una interconsulta urgente solicitada por sus hijos debido a un agravamiento drástico en su conducta: Ernesto presentaba episodios cotidianos de agitación intensa, accesos de furia verbal, sospechas delirantes de que "le robaban sus libros" y un rechazo sistemático a los cuidados de las enfermeras domiciliarias, a quienes amenazaba con arrojarles objetos.

La familia

Su hija mayor, exhausta y desbordada por la culpa, evaluaba la internación geriátrica definitiva, experimentando un profundo dolor al ver que su padre —un hombre de agudo intelecto y refinada cultura— se desvanecía en un mar de confusión y hostilidad.

Análisis desde la Clínica de la Convergencia



Un abordaje reduccionista biologicista clásico habría interpretado el cuadro de Ernesto como "trastornos conductuales y psicológicos de la demencia (BPSD)" y habría prescrito altas dosis de fármacos antipsicóticos sedantes para someter la agitación, corriendo el riesgo de acelerar el deterioro cognitivo y transformar al paciente en un autómatas postrado.

Un hermetismo psicoanalítico purista, por su parte, habría considerado que "con un paciente con demencia avanzada el psicoanálisis no tiene nada que hacer", abandonando a la familia a su suerte.

❏ La Clínica de la Convergencia leyó el padecimiento de Ernesto en su **pluridimensionalidad**.



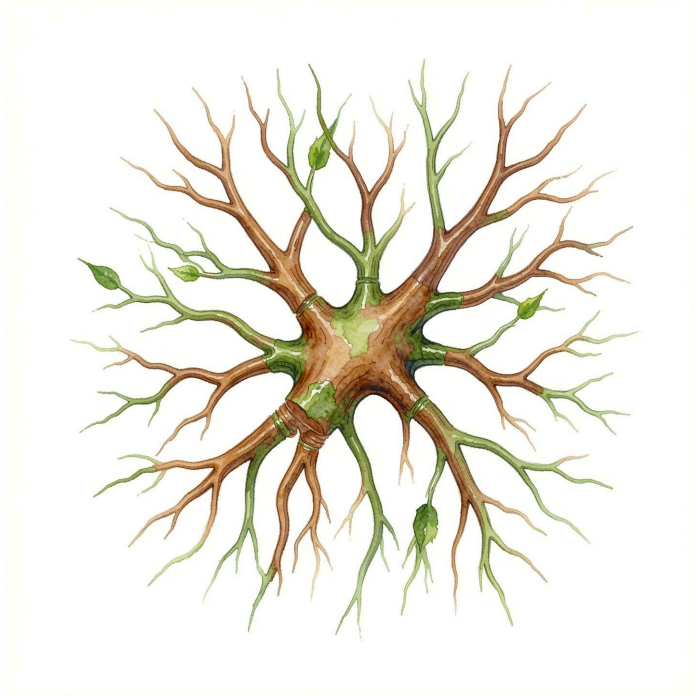
Dimensión 1: El Terror del Yo ante el Vacío y la Pérdida de Control

La furia como defensa

Las crisis de furia y las sospechas de robo no eran meros "síntomas neurológicos abstractos". Eran la respuesta defensiva desesperada de un yo que experimentaba cotidianamente la angustia catastrófica de no reconocer su propio hogar, de extraviarse en su propia mente y de perder el dominio de su mundo.

El robo como metáfora

Acusar de "robo" a los cuidadores era la única forma que encontraba su psiquismo para dar cuenta de una pérdida inasumible: le estaban robando su propia memoria y su identidad.



Dimensión 2: El Desborde Neurobiológico y la Habitación Abolida

Desde la perspectiva neurobiológica, el cerebro de Ernesto estaba sometido a un colapso de sus redes sinápticas.

Cada cambio en el entorno, cada rostro nuevo o cada indicación médica no familiar desencadenaba un **secuestro amigdalino inmediato**, inundando su organismo de adrenalina y sumiéndolo en el pánico.

Herramientas de Intervención Convergente



Reestructuración ambiental

Se rediseñó el entorno cotidiano reduciendo drásticamente la rotación de cuidadores y estableciendo rostros familiares y rutinas estables. Esta previsibilidad ambiental actuó como un sostén externo que redujo la activación amigdalina y aplacó la furia crepuscular.



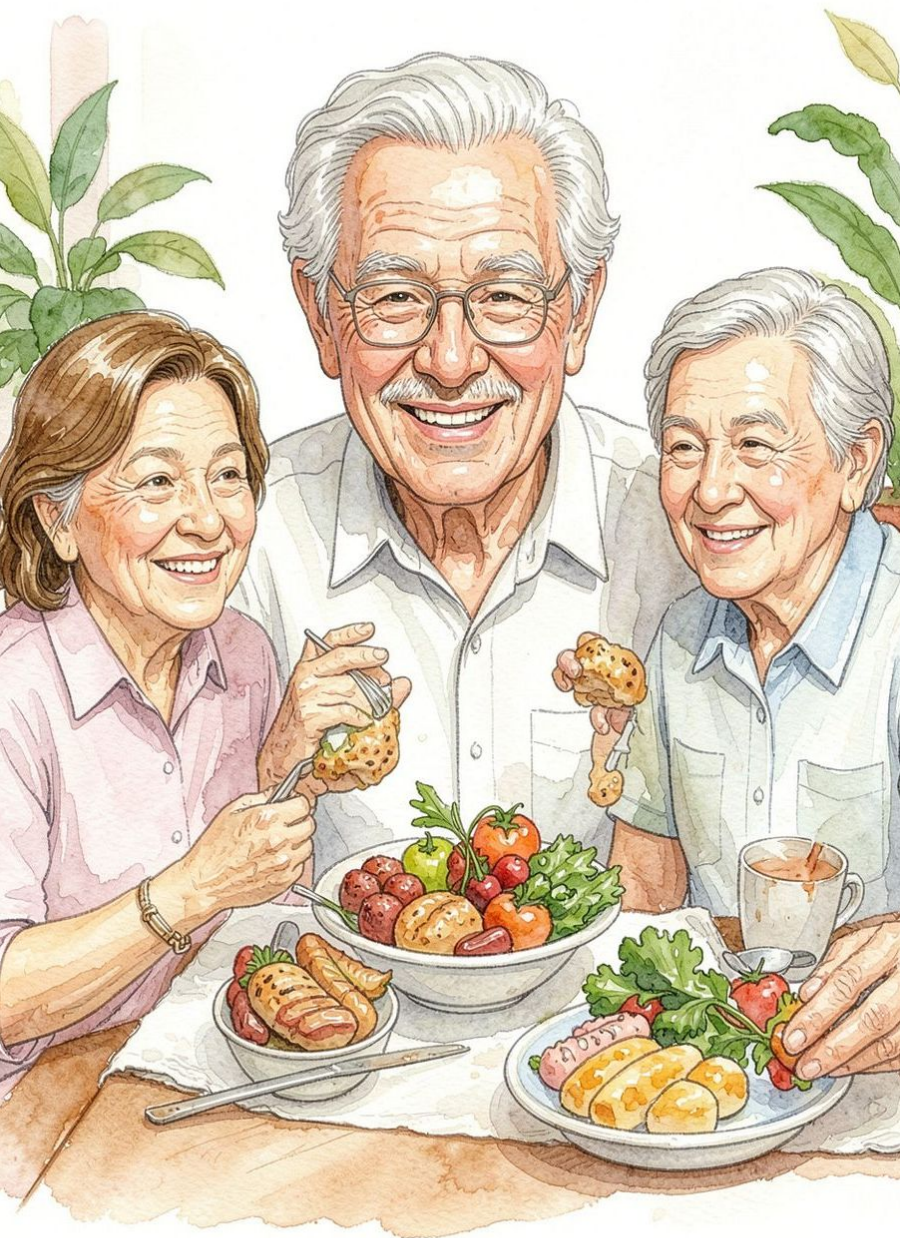
Articulación farmacológica de precisión

En coordinación con el equipo médico gerontológico, se retiraron los sedantes pesados y se utilizaron dosis mínimas de moduladores específicos orientados a calmar la ansiedad nocturna, preservando los islotes de lucidez en los que Ernesto aún podía sonreír, reconocer a su hija y conectar con fragmentos de su poesía amada.



Apuntalamiento vincular y mediación del afecto

Se trabajó intensamente con los hijos para modificar la modalidad del trato: comunicarse a través del registro afectivo, la música, la lectura en voz alta de fragmentos literarios y el contacto físico continente. Se elaboró el duelo anticipado de la hija, permitiéndole aceptar que el padre afectivo aún podía ser rescatado en el calor del presente compartido.



Desenlace Clínico

Gracias al abordaje convergente, los episodios de agitación furiosa de Ernesto remitieron de manera notable. Pudo permanecer en su hogar rodeado de sus afectos durante el año siguiente, transitando las etapas finales de su enfermedad con dignidad, sin sobremedicación sedante y con un vínculo familiar profundamente reparado.



Agitación

Remisión notable de los episodios de furia

1

Año en el hogar

Rodeado de sus afectos y su entorno familiar

0

Sobremedicación

Sin sedantes pesados, preservando la lucidez

Conclusión: La Vigencia de la Clínica de la Convergencia en el Ocaso de la Vida



El caso demuestra con absoluta contundencia la vigencia y la profunda humanidad de la Clínica de la Convergencia en el ocaso de la vida: cuando la neurodegeneración estropea el edificio de la razón, el analista, articulando el rigor de la metapsicología del afecto con la sensibilidad neurobiológica del cuidado, demuestra que ningún ser humano es nunca un "resto descartable", y que la palabra, la presencia y la ternura siguen siendo posibles hasta el último suspiro de la existencia.

- **Ningún ser humano es nunca un "resto descartable".** La palabra, la presencia y la ternura siguen siendo posibles hasta el último suspiro de la existencia.